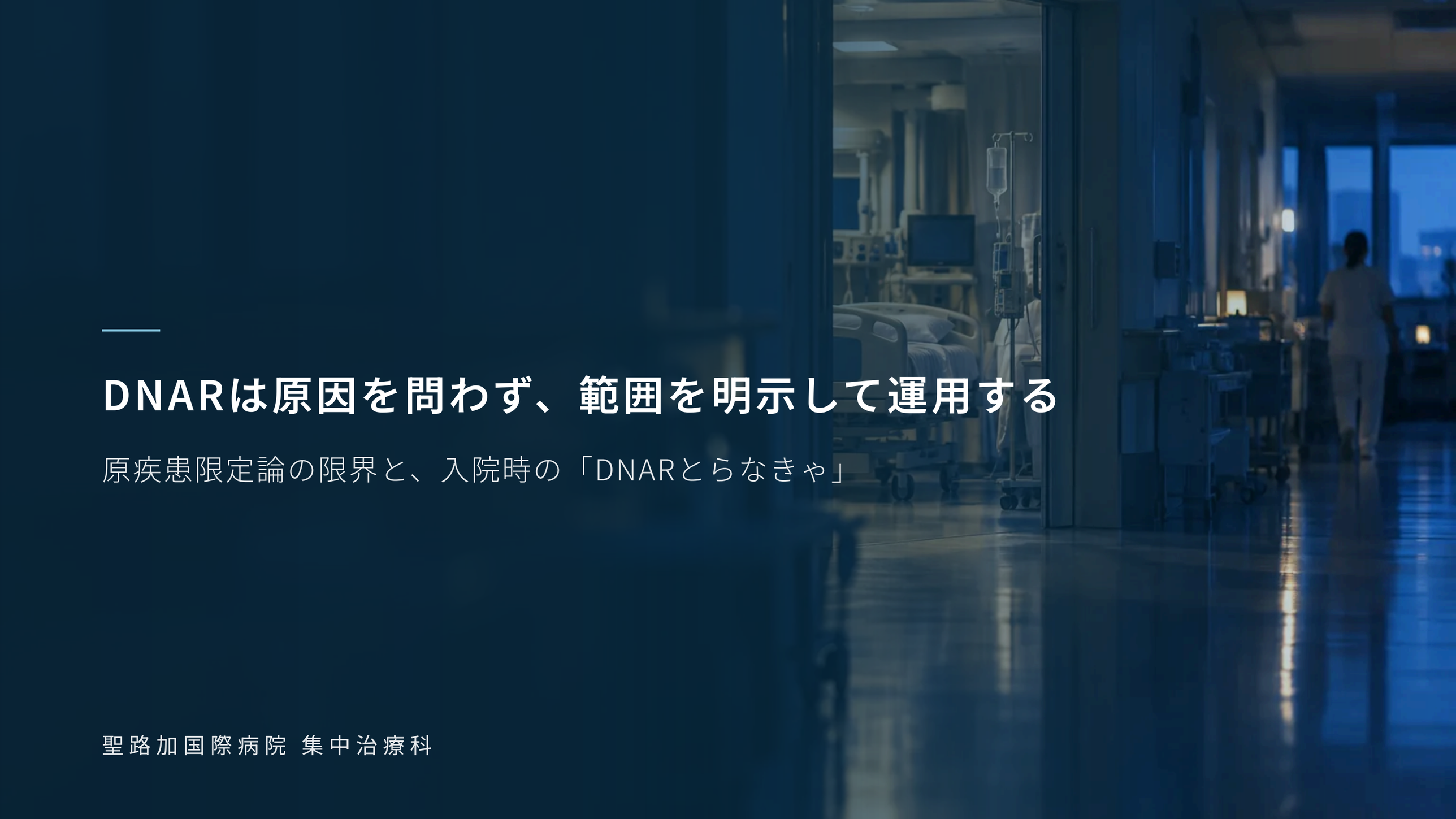


DNARは原因を問わず、範囲を明示して運用する

原疾患限定論の限界と、入院時の「DNARとらなきゃ」

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

DNARは「原因を問わず」と範囲で書く
看護師にその場で原因を判断させない。例外は事前に決める

2

フレイルは材料であって、結論ではない
決め手は本人にとってのゴール。単一の指標で線を引かない

3

入口では推定意思を聴き、経過で範囲を決める
入院時の一律の「DNARとらなきゃ」をやめる

第 1 章

01

症例とDNARの土台

話し合ったのに、意見が割れる

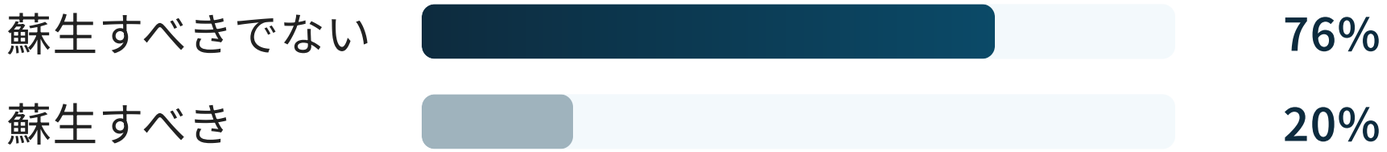
DNARの患者が心停止。蘇生するか

症例

90歳、要介護4。誤嚥性肺炎で入院7日目

家族と話し合ってDNAR。肺炎は改善傾向だったが、
訪室すると心停止していた

SNSのアンケート（3万票超）



前日の命題「DNARは原疾患の心停止だけに適用」には「正しい」が**34%**

出典：臨床医の note 論考（2026-10）で紹介されたアンケート

論点の核心

話し合ったかではなく、合意の解像度

原疾患に限るのか、原因を問わないのか

聖路加国際病院 集中治療科

DNARで決まること、決まらないこと

決まること	心停止時に、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬を**試みない**。有効なのは心停止時だけ
決まらないこと	心停止前の酸素・挿管・昇圧薬・抗菌薬・ICU入室。DNARを理由に**自動的に控えない**
行わないこと	部分的なDNAR（胸骨圧迫だけ等）と、形だけのスローコード
原疾患限定	学会の文書に「原疾患の心停止だけ」と定めたものは**見当たらない**

「心停止」を「急変時」にすり替えない

出典：日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、同 委員会報告（2016）、AHA 2025 倫理編

第 2 章

02

原疾患限定論の限界

原因はわからず、無益は原因を問わない

反論①：原因は、その場ではわからない

問い	酸素7 Lの肺炎患者が急に止まった。**肺炎のせい**なのか
発見者	見つけるのは多くが**夜の看護師**。その場で原因を判断させるのは無理がある
帰結	「発見したら原因にかかわらず蘇生」なら、それは**フルコード**

原因で線を引く指示は、現場で運用できない

反論②：無益は、原因を問わない

1

DNARの根拠の多くは、CPRの無益性
「その人にとって」利益がないという意味。資源やコストの話ではない

2

本人の拒否も、別の正当な根拠
AHAは、無益性と本人の拒否を並べて挙げている

3

原因がわからなくても、無益は変わらない
無益と見込まれない人に、医療者からDNARを持ち出す理由はない

出典：AHA 2025 倫理編

フレイルは、蘇生後の転帰と強く関連する

3.56
フレイルでCPR後の死亡オッズ比（7研究1,704例のメタ解析）

90.2%
フレイルありの死亡率（なしは71.6%）

0例
CFS 4超の院内心停止で生存退院（非フレイルは26%）

日本の前向き多施設研究（院外心停止）でも、発症前のCFSが高いほど30日後の神経学的転帰が悪い

出典：Hamlyn Resusc Plus 2022、Ibitoye Age Ageing 2021、Yamamoto Ann Emerg Med 2023

ただし、「蘇生するな」とまでは言っていない

閾値	CFSの区切りは研究ごとに違う（>4、≧5）。**一律の線は引けない**
研究の規模	90例の後ろ向き研究で「無益」と断定するのは言い過ぎ。生き延びた人のQOLの評価も要る
滑りやすい坂	後期高齢やADLの低さだけで終末期とはいえない。理由にすると適応がずるずる広がる

出典：Hamlyn Resusc Plus 2022、日本集中治療医学会 委員会報告（2016）

第２章のまとめ

フレイルは材料であって、結論ではない

医学の問いには答えるが、価値の問いには答えない

聖路加国際病院 集中治療科

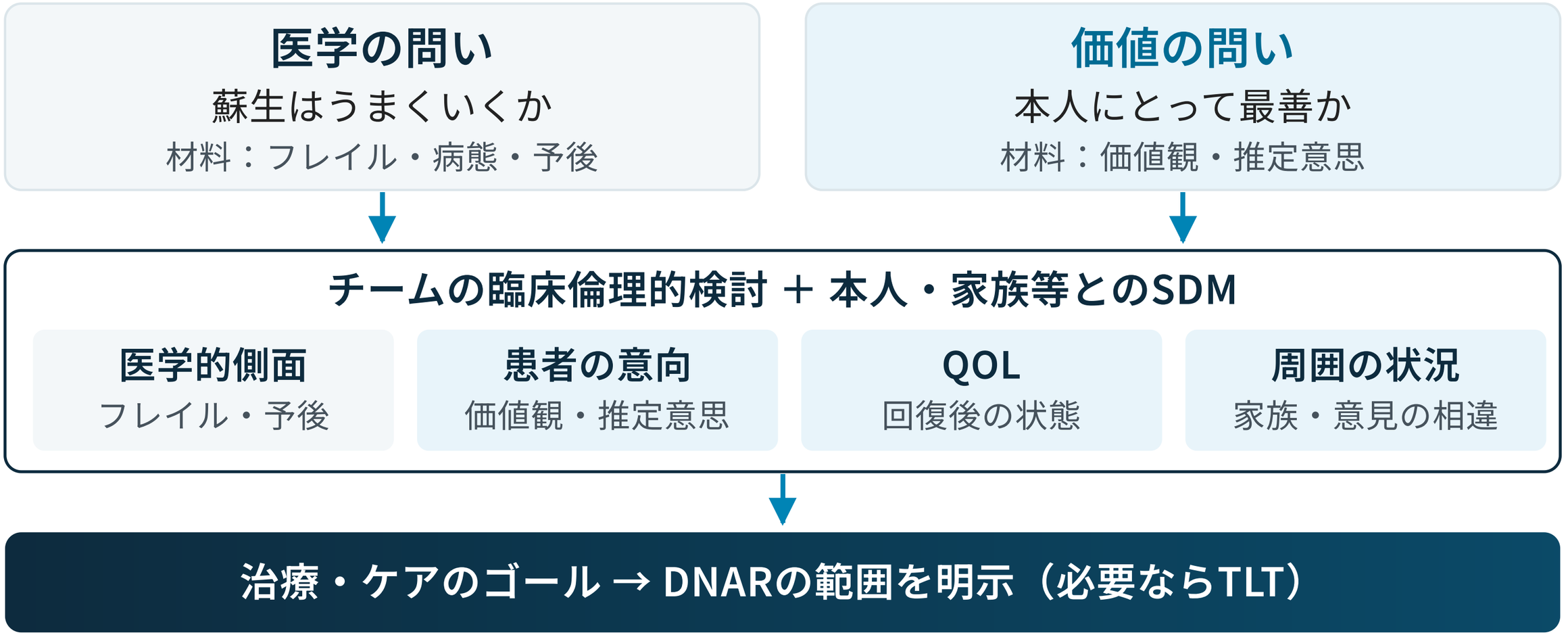
第 3 章

03

土俵を一段上げる

医学の問いと価値の問いを並べて量る

医学の問いと価値の問いを、並べて量る



4学会合同ガイドライン（2026）の構造をもとに作図

AHAも4学会GLも、手続きで決める

AHA 2025 倫理編

- 4原則を、どれも優先しない**均衡**で扱う
- 「利益がない」の判断にも価値観が入る
- 年齢を、生命維持治療を制限する唯一の決定因子にしない
- 価値観を引き出す方法がSDM

4学会合同ガイドライン（2026）

- **終末期を定義しない**。起点は治療・ケアのゴール
- 例示が「線」として読まれ、考えが止まった反省から
- 入院時に一律に設定する便宜的なDNARを否定
- DNARは**適用範囲の明確さ**が不可欠

出典：AHA 2025 倫理編（PMID 41122890）、4学会合同ガイドライン 本編・説明文・Q&A（2026）

第 4 章

04

入院時の「DNARとらなきゃ」

入口では、推定意思だけを聴く

入院の入口で

「蘇生はしませんよね」と聞いていないか

問われれば、家族はたいていうなずく

聖路加国際病院 集中治療科

入口で問われれば、ほぼ全員がうなずく

55.9%

日本の医療・介護関連肺炎（596例、平均81.5歳）で、DNARの意向確認が行われた割合

94%

確認された333例のうち同意した割合（313例）

1分

入院時のコードステータスの話し合い（中央値・録音研究）

録音された80件の入院面談で、話し合いは19件。予後に触れたのは1件、**推奨を述べた医師はいなかった**

出典：Imamura J Infect Chemother 2022（PMID 35414437）、Anderson J Gen Intern Med 2011（PMID 21104036）

一律の確認は、構造への防衛反応

既定値	指示がなければ**全例フルコード**
夜	その重さを、当直医が**一人で背負う**
現場の思い	望まれていない蘇生の記憶、手がかりのない判断の不安。どれも軽んじない
直すもの	人ではなく構造。**記録の形**と、悪化時に誰が支えて家族と話すか

出典：臨床医の note 論考（2026-10）の論点を整理

4つの違和感を、エビデンスで確かめる

違和感	一次資料	結論
① 入院時点で無益性は見積もれない	予測スコアは良好な転帰を**低く見積もる**。CFS 6以上でも16%は生存退院	**支持**
② 悪くなってからでも話し合える	病棟の心停止の84%は8時間以内に前兆。ただし蘇生を望まない人の約半数にしかDNR指示が出ていない	**半分支持** 声は早く聴く
③ 確認は誰のためか	DNR指示は予後より**年齢と施設**で動く。郡ごとに10倍の差	**輪郭が明確に**
④ 関係の入口として重すぎる	満足度に差はない。ただし話し合いは1分の儀礼に傾く	**支持されず** 問題は形

出典：Amacher 2022、Hu 2022、Schein 1990、Hakim 1996、Zingmond 2005、Anderson 2011（2本）

代案 A〜E

	すること	ポイント
A	入口では**推定意思だけ**を確認	「特に聞いていない」も正当な答え
B	蘇生を話すのは、数時間以内に判断が迫るとき	挿管・ICU入室など。治療目標の話し合いとして
C	経過の中で、必要なときに	悪化の兆し、反応が乏しい、家族からの問い
D	「しませんよね」と誘導しない	推奨は理由とともに率直に。**年齢だけは理由にならない**
E	記録を「共有された認識の進捗」に	回復の見込み・ゴール・推定意思。未記載は**プロセスの途中**

出典：臨床医の note 論考（2026-10）の代案を要約

入口の問いは「何か伺っていますか」

入口で聞くこと（要旨）

**「ご本人が大事にしてきたこと、
望まないと話していたことを、
何か伺っていますか」**

- 「特に聞いていない」も、**正当な答え**
- 本人がいれば、認知症があっても本人にも聞く
- 家族は「決める人」ではなく、**本人の声を運ぶ人**

出典：note 論考（2026-10）、Wendler Ann Intern Med 2011

看護師の不安には「暫定フルコード」で答える

看護師　コードステータスが書かれていないのですが…

医師　現時点では回復の見込みがあるので、心停止時は**暫定的にフルコード**。厳しくなれば、そのとき範囲を話し合って書きます

指示簿の書き方

コードステータス：暫定フルコード（状況により随時検討）

推定意思：**[伺った内容／特に聞いていない]**

次に話し合う契機：**[悪化の兆し／○月○日]**

一般論としての書き方。「暫定」は先送りではなく、進捗と次の契機を一緒に書く

入口の確認は、日本の手順を飛ばしている

厚労省プロセスGL（2018）

推定意思を尊重 →
推定できなければ最善を
家族等とチームで話し合う →
状態に応じて**繰り返し文書化**

JSICM DNAR勧告（2017）

DNARは心停止時のみ有効。
終末期医療とは**別に合意**し、
繰り返し評価する

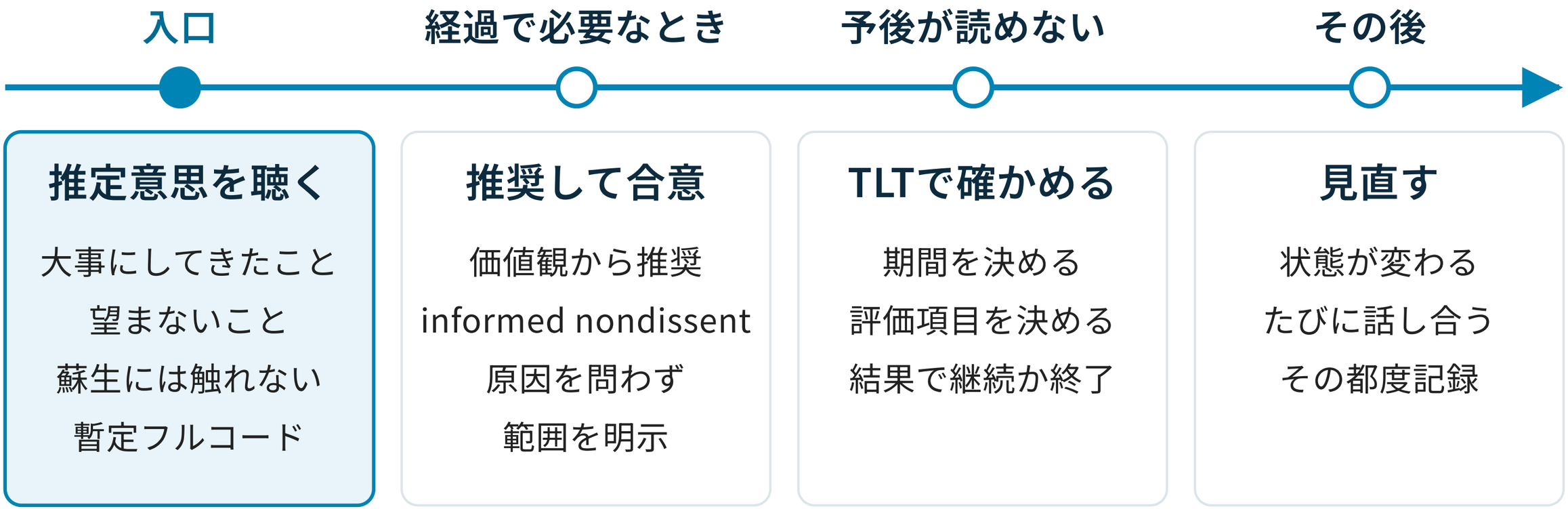
4学会GL Q&A（2026）

入院時に一律に設定する
便宜的なDNARを否定。
範囲の明確さを求める

「蘇生はしませんよね」は、チームの判断・推定意思・話し合い・繰り返しを全部飛ばす

出典：厚労省プロセスGL（2018）、JSICM DNAR勧告（2017）、4学会GL（2026）

入口では価値観を聴き、経過の中で範囲を決める



記録するのは「DNARの有無」ではなく「共有された認識の進捗」

厚労省プロセスGL・日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）・4学会合同ガイドライン（2026）の構造をもとに作図

第 5 章

05

範囲を明示して運用する

原因を問わず。例外は事前に

価値の判断は事前に、現場では指示に従う

看護師（発見者）

- その場で本人の価値観に立ち返らなくてよい
- 範囲が明確な指示に従う
- 範囲が曖昧で迷ったら、**蘇生を始めながら確認**

医師

- 事前の話し合いで、価値観を聴いてから推奨する
- はい／いいえで選ばせない
- 結果を**範囲の明確な指示**にしておく

出典：AHA 2025 倫理編

informed nondissent —— 拒否権を残す

言い方の例（要旨）

「伺ったお考えからすると、心臓が止まったときの蘇生は行わない方針がよいと考えます。」

「反対があればおっしゃってください。なければ、この方針で進めます。」

家族に**決断の重荷**を
負わせない

医療者が一方的に
決めるのでもない

使う前に、決定を
委ねたいかを確かめる

出典：AHA 2025 倫理編

窒息と、処置に伴う心停止

窒息の苦しさ	異物除去や吸引はCPRではない。**DNARと無関係**に行う
窒息後の心停止	CPRをするかは、原因ではなく**事前に合意した範囲**で決まる
処置に伴う心停止	可逆的で、処置への同意に回復が含まれうる。DNARを一時変更・解除するかを**事前に決める**

DNARのある80歳が内視鏡中の喉頭痙攣で心停止した場面で、医師の83.4%が「CPRをする」と回答（学会の調査）

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）

DNARの指示の書き方 —— 実装の一案

1

心停止時は原因を問わずCPRを行わない
発見者にその場で原因を判断させないため

2

窒息による心停止も含む
DNARを考える患者では十分に起こりうるため

3

処置に伴う心停止は、事前に扱いを決める
処置中に一時変更・解除するか

4

望む状態に戻れないと分かれば、終了を検討
始めたらやめられない、を外す

4学会GLが求めるのは「範囲を明確に」まで。これは<u>GLのルールではなく実装の一案</u>

一般論としての提案。施設ごとに倫理委員会などで検討して決める

第 6 章

06

TLTと3原則

時間を味方につける

TLTとACPは、車の両輪

ACP（事前の対話）
価値観を共有し、範囲の明確な指示にしておく

TLT（始めて確かめる）
例：7日間の人工呼吸で、臓器機能の回復と合併症を評価する

- 目標・再評価の日と指標・価値観との結びつきを、**始める前に**決める
- 「フルコードか、何もしないか」の二択から抜け出せる
- 「迷ったらとりあえず始める」の**免罪符にしない**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）

最終版の3原則

1

無益の見込みは「材料」であって「結論」ではない
フレイルなどからの予測は、医療者がDNARを考える重要な医学的材料

2

DNARは「原因を問わず」と範囲を明示して運用する
処置に伴う可逆的な心停止などは、例外として事前に検討する

3

単一の指標で線を引かない
ゴールをチームの検討とSDMで探り、必要ならTLTで確かめ、繰り返し見直す

2の「原因を問わず」はGLの一律のルールではなく、範囲を明確にするための実装の提案

第 7 章

07

記録と文例

有無ではなく、範囲と進捗を残す

文例0：入院時の記録は、話し合いの進捗

【入院時：推定意思の確認と話し合いの進捗】

- コードステータス：暫定フルコード（状況により随時検討）
  理由：**[現時点では回復の見込みがある]**
- 推定意思：**[家族等]** に、大事にしてきたこと・望まないことを尋ねた
  回答：「**[家族等が語った本人の言葉／特に聞いていない]**」
- 共有された認識：回復の見込み **[…]** ／向かうゴール **[…]**
  蘇生について：**[入口では話していない（判断が迫っていない）]**
- 次に話し合う契機：**[悪化の兆し／反応が乏しい／家族の問い／○月○日]**

［ ］は症例ごとに書き換える。施設の様式に合わせて直す

一般論としての文例。厚労省プロセスGL・4学会GLが求める記録項目に沿う

文例1：DNAR指示は、範囲で書く

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）

- 適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。
- 例外：**[内視鏡／CV挿入など]** 処置に伴う心停止の扱いは処置前に確認
- DNARを理由に控えない治療：酸素、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**[NIV]**
- 心停止前の治療（別に決定）：挿管 **[行う／行わない／TLT]**、透析 **[…]**
- 再評価：**[病状が変化したとき／○月○日／処置の前]**

面談記録には、本人の言葉・推定意思の根拠・推奨の形・参加者・保留事項も残す

一般論としての文例。4学会GLが求める記録項目に沿う

記録で避けること

「急変時DNR」「DNR取得」
範囲が曖昧で、治療全般を控える読み方を招く

「DNAR未取得」
主治医の怠慢のように読める。**進捗を書けば**
プロセスの途中と伝わる

「家族がDNARを希望」だけ
価値観・推定意思の根拠・推奨がなく、何を
合意したか残らない

チェック欄だけ
有無だけでは、範囲と理由が夜勤に伝わらない

DNAR指示の記録は9割、協議の過程の記録は7割（学会の調査）

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、4学会合同ガイドライン（2026）

明日から変える3つ

1

入口では「何か伺っていますか」と聞く
蘇生の可否を聞かない。暫定フルコードと書き、進捗を記録する

2

経過で話し合ったら、推奨してから合意する
「どうしますか」と選ばせない。拒否権は残す

3

DNARは「原因を問わず」と範囲で書く
例外は事前に決め、心停止前の治療は別に決める

ご清聴ありがとうございました

次の入院で、まず「何か伺っていますか」と聞いてみてください

聖路加国際病院 集中治療科

主な出典

- 日本集中治療医学会. DNAR指示のあり方についての勧告. 2017／委員会報告. 2016
- 日本集中治療医学会ほか4学会. 生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A）. 2026
- 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018
- Elmer J, et al. Part 3: Ethics. 2025 AHA Guidelines. Circulation 2025（PMID 41122890）
- Hamlyn J, Resusc Plus 2022／Ibitoye SE, Age Ageing 2021／Yamamoto R, Ann Emerg Med 2023／Hu FY, J Gen Intern Med 2022
- Imamura Y, J Infect Chemother 2022／Anderson WG, J Gen Intern Med 2011・Am J Hosp Palliat Care 2011
- Hakim RB, Ann Intern Med 1996／Zingmond DS, Arch Intern Med 2005／Schein RM, Chest 1990／Amacher SA, Crit Care 2022
- Wendler D, Ann Intern Med 2011／Dignam C, Aust Health Rev 2022／Dzeng E, Sociol Health Illn 2019

臨床医が note に書いた2本の論考を出発点に、論点を一次資料で確かめて整理した要約。原文の転載ではない。
写真は生成画像